ANNEXE I
RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

1.1 Dénomination commerciale, dosage et forme pharmaceutique

DOLIPRANE 2.4 POUR CENT SANS SUCRE, SUSPENSION BUVABLE A LA SACCHARINE SODIQUE ET AU SORBITOL, Suspension buvable, 2.4%

1.2 Dénomination commune internationale (DCI)

Paracétamol

2.COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

2.1 Description générale

La substance active est : paracétamol 120 mg dans chaque 5 ml de suspension

Les excipients : benzoate de sodium, sorbate de potassium, sorbitol, glycérol 85%, gomme de xanthane, acide citrique monohydraté, saccharine sodique, arôme de fraise, eau purifiée.

2.2 Formule centésimale

Paracétamol ..... 2.400 g

Pour 100 ml

Excipient à effet notoire : Sorbitol, Glycérol, Benzoate de sodium et Potassium

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Suspension buvable

Description du médicament : suspension visqueuse quasi blanche à beige foncé avec un arôme de fraise des bois.

4. DONNEES CLINIQUES

4.1. Indications thérapeutiques

DOLIPRANE 2.4 POUR CENT SANS SUCRE, suspension buvable à la saccharine sodique et au sorbitol est destiné au traitement de :

- La fièvre, particulièrement pour traiter les infections bactériennes et virales aiguës,
- La douleur dentaire (y compris la douleur associée à la poussée dentaire), les céphalées, la névralgie, des douleurs musculaires ou articulaires d'étiologie non inflammatoire.

Le produit est destiné aux enfants dès l'âge de 3 mois.

4.2. Posologie et mode d'administration

Le produit est destiné à être utilisé chez les enfants.

Chez les enfants à partir de 3 mois, une dose individuelle de 10 à 15 mg de paracétamol / kg de masse corporelle doit être utilisée pour le traitement de la fièvre et de la douleur.

Il est administré selon les besoins dans les intervalles de 6 heures, l'intervalle peut être raccourci, si nécessaire, à 4 heures, mais une dose quotidienne totale ne doit pas être dépassée.
Ne pas administrer plus de 4 doses dans les 24 heures.

La dose quotidienne totale ne doit pas dépasser 60 mg / kg de masse corporelle chez les enfants de moins de 6 ans, 1 500 mg chez les enfants de 6 à 12 ans avec une masse corporelle de 21 à 25 kg et 2 000 mg chez les enfants de 26 à 40 kg.

Le tableau permet de définir la bonne dose en fonction du poids de l'enfant. Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, utilisez l'âge de l'enfant pour déterminer la dose de médicament.

Age de l'enfant	**Poids corporel**	**Dose unique**		**Dose Max. quotidienne**
3 - 6 mois	5 - 6 kg	72 mg de paracétamol	3 ml de suspension	360 mg de paracétamol
	7 - 8 kg	96 mg de paracétamol	4 ml de suspension	420 mg de paracétamol
6 – 12 mois	9 – 10 kg	120 mg de paracétamol	5 ml de suspension	540 mg de paracétamol
1 – 2 ans	11 – 13 kg	144 mg de paracétamol	6 ml de suspension	660 mg de paracétamol
2 – 3 ans	14 - 16 kg	192 mg de paracétamol	8 ml de suspension	840 mg de paracétamol
3 - 6 ans	17 – 20 kg	240 mg de paracétamol	10 ml de suspension	1 g de paracétamol
6 – 12 ans	21 – 25 kg	312 mg de paracétamol	13 ml de suspension	1,5 g de paracétamol
	26 – 33 kg	384 mg de paracétamol	16 ml de suspension	2 g de paracétamol
	34 – 40 kg	480 mg de paracétamol	20 ml de suspension	2 g de paracétamol

Le produit est conçu pour les enfants, s'il est administré dans des cas exceptionnels à des adolescents ou des adultes, les doses de paracétamol sont les suivantes : adolescents ou adultes, les doses de paracétamol doivent être comme suit :

Age de l'enfant	**Poids corporelle**	**Dose unique**	**Dose Max. quotidienne**
12 – 15 ans	40 - 50 kg	500 mg de paracétamol	3 g de paracétamol
Plus de 15 ans	≤ 50 kg	500 mg de paracétamol	4 g de paracétamol
	> 50 kg	500 – 1000 mg de paracétamol	

Insuffisance rénale et/ou hépatique

Pour les patients présentant une insuffisance rénale grave avec des taux de clairance de la créatinine < 10 ml/min, l'intervalle entre les doses individuelles doit être d'au moins 8 heures. Avec une clairance de la créatinine comprise entre 10 et 50 ml/min, l'intervalle entre les doses individuelles doit être d'au moins 6 heures.

En cas d'atteinte de la fonction hépatique, les doses maximales ne doivent pas être administrées et l'intervalle entre les doses individuelles doit être d'au moins 6 heures.

Mode d'administration :

Chaque conditionnement contient une cuillère doseuse graduée en ml.

1- Bien agiter le contenu de la bouteille fermée (pendant 5 secondes environ).

2- Le flacon est scellé avec un bouchon de sécurité enfant. Pour l'ouvrir, appuyez doucement et dévissez le bouchon dans le sens anti-horaire.

3- Après utilisation, refermer le flacon en vissant à nouveau soigneusement le bouchon.

Après avoir avalé la suspension, boire suffisamment de liquide non irritant.

Instructions sur la façon d'ouvrir le flacon médicinal avec la fermeture de sécurité

Le flacon médicinal est fourni avec une fermeture de sécurité inviolable pour enfants. Ouvrir en appuyant fermement sur le bouchon vers le bas et dévisser dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Après utilisation, bien visser le bouchon à nouveau.

4.3. Contre-indications

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique « Liste des excipients ».
- Formes sévères d'insuffisance hépatique.
- Hépatite aiguë.

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Il est nécessaire de prendre des précautions particulières lors de l'administration du produit aux patients présentant un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase, une anémie hémolytique et en cas d'administration concomitante de médicaments affectant le foie.

En cas d'insuffisance rénale, il est recommandé de prolonger l'intervalle entre les administrations (voir la rubrique 4.2). En cas de traitement à long terme, la possibilité d'une insuffisance rénale ne peut pas être exclue.

Chez les patients présentant des modifications de la fonction hépatique et chez les patients prenant des doses élevées de paracétamol à long terme (plus de 10 jours), un bilan hépatique régulier est recommandé.
L'utilisation de doses plus élevées que les doses recommandées pourrait entraîner un risque de déficience sévère de la fonction hépatique. Les patients souffrant d'une maladie hépatique ont un risque plus élevé de surdosage.

Les patients doivent être avertis qu'ils ne doivent pas prendre ce produit simultanément avec d'autres produits contenant du paracétamol.

D'après l'expérience post-AMM avec la prise de paracétamol, il a été découvert qu'une hépatotoxicité liée au paracétamol peut également se produire lors de l'utilisation de doses thérapeutiques, en particulier lors de l'utilisation d'une dose quotidienne de 4 g (dose thérapeutique maximale), dans le cadre d'une utilisation à court terme et chez les patients sans antécédents d'atteinte de la fonction hépatique. Une atteinte de la fonction hépatique peut se développer avec des doses plus faibles en présence de l'effet supplémentaire de l'alcool, des inducteurs d'enzymes hépatiques ou d'une autre substance hépatotoxique. La consommation d'alcool à long terme augmente considérablement le risque d'une hépatotoxicité liée au paracétamol.

Le produit est destiné aux enfants, mais si, dans un cas exceptionnel, il doit être utilisé par des adultes, ceux-ci doivent être avertis qu'ils ne peuvent pas consommer de boissons alcoolisées au cours du traitement.

La prudence est recommandée en cas d'administration concomitante de paracétamol et de flucloxacilline en raison d'un risque accru d'acidose métabolique à trou anionique élevé (AMTAE), en particulier chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère, de septicémie, de malnutrition et d'autres sources de déficit en glutathion (par exemple, alcoolisme chronique), ainsi que chez ceux qui utilisent des doses quotidiennes maximales de paracétamol. Une surveillance étroite, incluant la mesure de la 5-oxoproline urinaire, est recommandée.

Une vérification du temps de prothrombine est nécessaire pendant le traitement par anticoagulants oraux et avec l'administration concomitante à long terme de doses élevées de paracétamol, en particulier en association avec du dextropropoxyphène ou de la codéine.

La prudence est recommandée chez les patients présentant une sensibilité accrue à l'acide acétylsalicylique et/ou à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) en raison de la possible sensibilité croisée au paracétamol observée chez les patients sensibles à l'acide acétylsalicylique (AAS). Il peut y avoir des symptômes similaires à ceux observés après l'administration d'AAS (bronchospasme, réaction nasale-oculaire).

De très rares cas de réactions cutanées sévères ont été rapportés.

<u>Excipients</u>

Ce médicament contient 10 g de sorbitol à la dose individuelle la plus élevée (20 ml), équivalent à 500 mg de sorbitol dans 1 ml de suspension buvable. L'effet additif des produits contenant du sorbitol (ou du fructose) administrés concomitamment et l'apport alimentaire de sorbitol (ou de fructose) doit être pris en compte. La teneur en sorbitol dans les médicaments à usage oral peut affecter la

biodisponibilité d'autres médicaments à usage oral administrés de façon concomitante. Les patients présentant une intolérance héréditaire au fructose (IHF) ne doivent pas recevoir ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium à la dose individuelle la plus élevée de 20 ml de suspension buvable, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

Ce médicament contient 60 mg de benzoate de sodium à la dose individuelle la plus élevée de 20 ml, équivalent à 3 mg de benzoate de sodium dans 1 ml de suspension buvable.

4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Les substances hépatotoxiques peuvent augmenter la probabilité d'une accumulation et d'un surdosage de paracétamol.

Acide acétylsalicylique et chloramphénicol
Le paracétamol augmente les taux plasmatiques d'acide acétylsalicylique et de chloramphénicol.

Substances hépatotoxiques et inducteurs des enzymes hépatiques
Le risque d'une toxicité associée au paracétamol peut être augmenté chez les patients utilisant d'autres substances ou médicaments potentiellement hépatotoxiques induisant des enzymes hépatiques microsomales, par exemple, certains antiépileptiques (par exemple, le glutéthimide, le phénobarbital, la phénytoïne, la carbamazépine, la primidone, le topiramate), la rifampicine, les barbituriques, les inhibiteurs de la MAO, les antidépresseurs tricycliques, le millepertuis et l'alcool. L'induction métabolique entraîne une augmentation de la production du métabolite hépatotoxique oxydant du paracétamol. Les effets hépatotoxiques se produiront si ce métabolite dépasse la capacité de fixation normale du glutathion.

Cholestyramine
L'effet de la cholestyramine peut entraîner un ralentissement de l'absorption du paracétamol.

Probénécide
Le probénécide affecte l'élimination et la concentration plasmatique du paracétamol.

Zidovudine
L'utilisation concomitante de paracétamol et de zidovudine crée une tendance accrue au développement d'une neutropénie et d'une hépatotoxicité. Ce n'est donc qu'après un examen minutieux des risques et bénéfices du traitement que ce médicament sera utilisé en concomitance avec la zidovudine.

Lamotrigine
Une baisse de l'efficacité de la lamotrigine et une élévation de sa clairance hépatique ont été observées lors de l'utilisation concomitante de paracétamol et de lamotrigine.

Propanthéline
Une utilisation concomitante de médicaments et produits ralentissant la vidange de l'estomac, tels que par ex. la propanthéline, peut entraîner un ralentissement de l'absorption du paracétamol et du début de son effet.

Warfarine et anti-vitamine K
L'effet anticoagulant de la warfarine ou d'autres antagonistes de la vitamine K peut être augmenté avec un risque accru de saignement pendant l'utilisation quotidienne régulière à long terme du paracétamol avec ces produits. Les interactions susmentionnées ne sont pas cliniquement significatives si le produit est utilisé conformément à la posologie et à la durée du traitement recommandées. Les patients prenant du paracétamol et des antagonistes de la vitamine K doivent être surveillés pour déterminer s'ils présentent une coagulation adéquate et aucune complication hémorragique.

Flucloxacilline
Il convient d'être prudent lors de l'utilisation concomitante de paracétamol et de flucloxacilline, car la prise simultanée a été associée à une acidose métabolique à trou anionique élevé, en particulier chez les patients présentant des facteurs de risque (voir rubrique 4.4).

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et acide acétylsalicylique
Une administration concomitante à long terme de paracétamol et d'AINS (en particulier, l'acide acétylsalicylique) à des doses élevées augmente le risque de néphropathie des analgésiques et d'autres effets rénaux indésirables.

Isoniazide

Certains rapports indiquent que l'isoniazide peut augmenter le potentiel hépatotoxique du paracétamol. En cas d'administration concomitante, les signes cliniques et biologiques d'hépatotoxicité doivent être étroitement surveillés.

Alcool La consommation d'alcool pendant le traitement par le paracétamol peut entraîner la création d'un métabolite toxique déclenchant la nécrose des cellules du foie et causant même éventuellement une insuffisance hépatique.

4.6. Fertilité, grossesse et allaitement

Le produit est destiné aux enfants, mais s'il est utilisé par une femme adulte, les informations suivantes s'appliquent :

Grossesse La grande quantité de données disponibles chez les femmes enceintes n'a pas indiqué de malformation, ni d'effet toxique sur le fœtus/nouveau-né. Les résultats des études épidémiologiques de développement neurologique chez les enfants exposés *in utero* au paracétamol n'ont apporté aucune preuve. Si cela est nécessaire sur le plan clinique, le paracétamol peut être utilisé pendant la grossesse, cependant, il doit être utilisé à la dose la plus faible possible, pendant la durée la plus courte possible et à la fréquence la plus faible possible.

Allaitement
Après administration orale, le paracétamol passe dans le lait maternel, les quantités qui passent ne sont pas cliniquement significatives. Un traitement par le paracétamol à court terme ne nécessite pas l'interruption de l'allaitement tant que le bébé allaité est étroitement surveillé. Aucun effet indésirable n'a été observé chez les bébés allaités, pas même en cas de traitement à long terme avec du paracétamol, à l'exception d'un cas d'exanthème maculopapuleux.

4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Sans objet, le produit est destiné à être utilisé chez les enfants. Le produit n'affecte pas la capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

4.8. Effets indésirables

Le tableau suivant synthétise les effets indésirables avec leur incidence – très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

Base de données MedDRA des classes de systèmes d'organes	Fréquence	Effet indésirable
Affections hématologiques et du système lymphatique	Très rare	Agranulocytose, leucopénie, neutropénie, pancytopénie, thrombopénie
Affections hépatobiliaires	Très rare	Ictère
	Fréquence indéterminée	Hépatite cytolytique pouvant entraîner une insuffisance hépatique aiguë
Affections du métabolisme et de la nutrition	Fréquence indéterminée	Acidose pyroglutamique, chez les patients présentant des facteurs prédisposant à la déplétion du glutathion.
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales	Très rare	Bronchospasme
Affections du système immunitaire	Très rare	Choc anaphylactique, angiocœdème
Affections de la peau et du tissus sous-cutané	Rare	Dermite allergique, rash, urticaire*
	Très rare	Très rarement, des réactions cutanées sévères et des exanthèmes médicamenteux fixes ont été rapportées. (voir rubrique 4.4)*

* En cas de survenue d'au moins un des effets indésirables mentionnés ci-dessus, ce médicament doit être définitivement arrêté.

Déclaration des effets indésirables suspectés :

Centre National de Pharmacovigilance et de Matériovigilance Sis, NIPA, Nouvel Institut Pasteur d'Algérie, Dely Ibrahim. Tél. /Fax : 023.36.75.02/ 023.36.75.27/02336.75.29. E-mail : cnpm@cnpm.org.dz

4.9. Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes)

Un surdosage avec des doses relativement faibles de paracétamol (8 à 15 g en fonction du poids du patient) peut entraîner un trouble sévère de la fonction hépatique et parfois une nécrose tubulaire aiguë. Un trouble de la fonction hépatique peut survenir après l'ingestion d'au moins 5 grammes de paracétamol chez des patients présentant des facteurs de risque tels que :

- Un traitement à long terme avec des inducteurs enzymatiques (carbamazépine, glutéthimide, phénobarbital, phénytoïne, rifampicine, primidone, millepertuis,
- Consommation régulière de très grandes quantités d'alcool,
- L'épuisement probable des réserves de glutathion (par exemple, en cas de trouble alimentaire, de mucoviscidose, d'infection par le VIH, de jeûne, de cachexie).

Symptômes

Dans les 24 heures, des nausées, des vomissements, une anorexie, une pâleur, une léthargie et de la transpiration peuvent apparaître chez le patient Les douleurs abdominales peuvent être le premier symptôme de trouble de la fonction hépatique et se produisent dans les 24 premières heures. Il peut y avoir une cytolyse hépatique, ce qui peut entraîner une insuffisance hépatique, un saignement gastrointestinal, une encéphalopathie, le coma et la mort. Les complications de l'insuffisance hépatique incluent une acidose métabolique, un œdème du cerveau, des manifestations hémorragiques, une hypoglycémie, une hypotension, des infections et une insuffisance rénale. Des cas de coagulation intravasculaire disséminée ont été observés dans un contexte de surdosage au paracétamol. Dans les 12 à 48 heures après un surdosage aigu, les taux d'aminotransférase, de lactate déshydrogénase et de bilirubine dans le foie augmentent, accompagnés par une baisse du taux de prothrombine. L'extension du temps de prothrombine est un signe d'exacerbation de la fonction hépatique; il est donc recommandé de le contrôler. Les patients qui utilisent des inducteurs enzymatiques (carbamazépine, phénytoïne, barbituriques, rifampicine) ou qui ont des antécédents d'abus d'alcool sont plus susceptibles de développer un trouble de la fonction hépatique. Une insuffisance rénale aiguë peut survenir même en l'absence de trouble grave de la fonction hépatique. D'autres manifestations d'une intoxication comprennent une altération du myocarde, une pancréatite et une pancytopénie.

Traitement

L'instauration immédiate d'un traitement est essentielle. Malgré l'absence de symptômes précoces, les patients doivent être immédiatement transférés à l'hôpital pour obtenir une assistance médicale immédiate. Les symptômes peuvent être limités à des nausées ou des vomissements et peuvent ne pas refléter la gravité du surdosage ou le risque de déficience d'organes. L'utilisation de charbon actif peut être envisagée jusqu'à 1 heure après le surdosage. Les concentrations plasmatiques de paracétamol doivent être mesurées 4 heures ou plus après l'ingestion (plus tôt, les concentrations ne sont pas fiables). Le traitement par N-acétylcystéine peut être utilisé dans les 24 heures suivant l'ingestion de paracétamol, mais l'effet protecteur maximal est obtenu s'il a été administré dans les 8 heures suivant l'ingestion. L'efficacité de l'antidote baisse drastiquement une fois cet intervalle dépassé. Si nécessaire, le patient doit recevoir de la N-acétylcystéine par voie intraveineuse conformément aux protocoles posologiques. Si le patient ne vomit pas, l'administration orale de méthionine est une alternative appropriée si le patient ne se trouve pas à l'hôpital.

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

5.1. Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique : autres analgésiques, antipyrétiques, anilides, Code ATC : N02BE01.

Le paracétamol est un analgésique-antipyrétique sans activité antiphlogistique et avec une bonne tolérance gastro-intestinale, adapté aux patients pédiatriques et adultes. Il n'affecte pas la glycémie et convient donc aux diabétiques. Étant donné qu'il n'affecte pas significativement la coagulation sanguine, même chez les patients sous anticoagulants oraux, il peut également être utilisé chez les

personnes hémophiles. Il n'affecte pas le niveau d'acide urique et son élimination dans l'urine. Il peut être utilisé dans tous les cas où les salicylates sont contre-indiqués.

5.2. Propriétés pharmacocinétiques

Absorption

Le paracétamol est rapidement et presque complètement absorbé par le tractus gastro-intestinal.

Distribution

Il est rapidement distribué à tous les tissus et fluides corporels. Les concentrations plasmatiques maximales sont atteintes dans les 30 à 60 minutes suivant l'administration orale. Il traverse la barrière hémato-encéphalique, dans la salive et le lait maternel.

Métabolisme et élimination

Il est métabolisé de façon intensive ; outre les réactions de conjugaison, il existe aussi des processus oxydatifs qui créent également des métabolites toxiques. Lors de l'administration de doses thérapeutiques, il y a une biotransformation rapide de ces métabolites hépatotoxiques intermédiaires, avec la création concomitante de glutathion et la création d'acides mercapturiques éliminés dans l'urine principalement sous la forme de conjugués ; moins de 5 % de paracétamol est éliminé dans une forme non altérée. La demi-vie biologique varie entre 1 et 3 heures, en cas d'insuffisance hépatique grave, elle peut être de maximum 5 heures. En cas d'insuffisance rénale, elle n'est pas étendue, mais étant donné qu'il est principalement éliminé dans les reins, la dose de paracétamol doit être réduite.

5.3. Données de sécurité préclinique

La toxicité du paracétamol a été étudiée en détail dans de nombreuses espèces animales.

a) Toxicité aiguë

La LD50 orale chez le rat est 3,7 g/kg et de 338 mg/kg chez la souris.

b) Toxicité chronique

Dans les études de toxicité sous-chronique et chronique du paracétamol chez des rats et des souris de laboratoire, des troubles du tractus gastro-intestinal, des changements de la numération globulaire ou une dégénérescence du parenchyme hépatique et rénal, résultant même en une nécrose, ont été observés. Ces changements sont liés à la fois au mécanisme d'action et au métabolisme du paracétamol. Les métabolites du paracétamol, auxquels les effets toxiques sont attribués, et les modifications des organes associés ont été démontrées aussi chez l'homme. Pour cette raison, le paracétamol ne doit pas être utilisé à long terme à des doses élevées.

c) Potentiel mutagène et cancérigène

Les résultats des études génotoxiques avec le paracétamol ne sont pas clairs. L'effet du paracétamol est fortement tributaire de la concentration utilisée et également du délai d'action. L'effet cancérigène du paracétamol a été observé uniquement après l'administration de doses élevées, hépatotoxiques. À des doses thérapeutiques normales, l'utilisation de paracétamol n'est pas associée à une génotoxicité et une carcinogénicité.

d) Toxicité pour la reproduction

Des études chez les animaux de laboratoire n'ont fourni aucune preuve d'une embryotoxique ou d'une foetotoxique du paracétamol.

Des études conventionnelles utilisant les normes actuellement reconnues pour l'évaluation de la toxicité pour la reproduction et le développement ne sont pas disponibles.

6. DONNEES PHARMACEUTIQUES

6.1. Liste des excipients

Liste des excipients : benzoate de sodium, sorbate de potassium, sorbitol, glycérol 85%, gomme de xanthane, acide citrique monohydraté, saccharine sodique, arôme de fraise, eau purifiée.

6.2. Incompatibilités

Sans objet.

6.3. Durée de conservation, si nécessaire après reconstitution du médicament ou lorsque le conditionnement primaire est ouvert pour la première fois

24 mois. 6 mois après ouverture.

6.4. Précautions particulières de conservation

Garder hors de portée et de vue des enfants.
Conserver en dessous de 25°C dans le flacon hermétiquement fermé à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Utiliser dans un délai de 6 mois après première ouverture.

6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur

Boite de 1 flacon en verre de 125 ml + 1 cuillère doseuse graduée en ml.

6.6. Précautions particulières d'élimination et de manipulation des médicaments utilisés ou des déchets dérivés de ces médicaments, le cas échéant

Pas d'exigences particulières.

7. CONDITIONS DE DELIVRANCE

Médicament non soumis à une prescription médicale.

8. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES :

8.1 Nom et adresse du détenteur de la décision d'enregistrement

PROPHARMAL SPA
Zone d'activités Amara, groupe 04, lot 509 et 510, route Ouled Fayet, Cheraga. Alger

8.2 Nom et adresse de l'exploitant de la décision d'enregistrement

PROPHARMAL SPA
Zone d'activités Amara, groupe 04, lot 509 et 510, route Ouled Fayet, Cheraga. Alger

8.3 Nom et adresse des différents intervenants dans la fabrication du produit fini, le site de production des : produits intermédiaires/ vrac / conditionnements (primaire et secondaire)

8.3.1 Fabrication du produit fini, conditionnement primaire et secondaire

SANOFI AVENTIS ALGERIE SPA
Zone industrielle de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, Commune de Rahmania, Alger. Algérie

8.3.2 Libération des lots

PROPHARMAL SPA
Zone d'activités Amara, groupe 04, lot 509 et 510, route Ouled Fayet, Cheraga. Alger

8.4. Numéro de la décision d'enregistrement

24/13/03 B 117/201

8.5. Date de mise à jour du texte

21/07/2022

9. Pour les médicaments radio pharmaceutiques, détails complets sur la dosimétrie interne des rayonnements ;

Sans objet

10. Conditions ou restrictions en vue d’une utilisation sure et efficace du médicament ;

Sans objet

11. Pour les médicaments radio pharmaceutiques, instructions supplémentaires détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de qualité de cette préparation et, le cas échéant. Période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluât ou le médicament radio pharmaceutique prêt à l'emploi, répond aux spécifications prévues.

Sans objet
